Gestione del paziente colonizzato/infetto in ambiente ospedaliero

Data	Redazione	Verifica	Approvazione
29/12/2017	Referente Gruppo di redazione Carolina Degl'Innocenti Cinzia Melchiori Emanuela Spadini	**Processo** Direttore SOS Infezioni Correlate all'Assistenza Anna Poli **SGQ** Direttore Documentazione sanitaria e mediazione linguistica e culturale Mauro Romilio	Direttore Sanitario Aziendale USL Toscana Centro Emanuele Gori

Copia non originale

Gruppo di redazione:

D. Accorgi, Infermiere Direzione sanitaria ospedale NOP, Azienda USL Toscana centro;
C. Adamo, Dirigente medico Direzione sanitaria ospedale SMN, Azienda USL Toscana centro;
C. Barchielli, Infermiera Direzione sanitaria ospedale SMA, Azienda USL Toscana centro;
S. Baretti, Dirigente medico U.F.C Igiene Pubblica e Nutrizione Setting Firenze, Azienda USL Toscana centro;
S. Brugnoli, Dirigente medico Direzione sanitaria ospedale SGD, Azienda USL Toscana centro;
P. Blanc, Direttore SOC Malattie Infettive 1, Azienda USL Toscana centro;
P. Capanni, Infermiera Direzione sanitaria medica SERRISTORI, Azienda USL Toscana centro;
C. Cecchini, Infermiera Direzione sanitaria medica PISTOIA, Azienda USL Toscana centro;
E. Cocchi, Direttore SOS Direzione medica di presidio "Piero Palagi", Azienda USL Toscana centro;
C. Degl'Innocenti, Assistente sanitaria, SOS Vigilanza e Controllo Infezioni Correlate all'Assistenza, Azienda USL Toscana centro;
M. Di Pietro, Direttore SOC Malattie Infettive 2 Pistoia-Prato, Azienda USL Toscana centro;
M. Donatini, Infermiere-Direzione sanitaria medica MUGELLO, Azienda USL Toscana centro;
P. Filidei, Dirigente medico U.F.C Igiene e Sanità Setting Empoli, Azienda USL Toscana centro;
D. Manetti, Infermiera-Direzione sanitaria medica SMN, Azienda USL Toscana centro;
A. Mani, Direttore SOS Medicina Preventiva, Azienda USL Toscana centro;
F. Mannocci, Dirigente medico Direzione sanitaria medica NOP, Azienda USL Toscana centro;
C. Melchiori, Infermiera-SOS Vigilanza e Controllo Infezioni Correlate all'Assistenza, Azienda USL Toscana centro;
G. Niccolai, Dirigente medico Direzione sanitaria medica Pistoia, Azienda USL Toscana centro;
D. Padrini, Dirigente medico SOS Vigilanza e Controllo Infezioni Correlate all'Assistenza, Azienda USL Toscana centro;
A. Poli, Direttore di struttura SOS Vigilanza e Controllo Infezioni Correlate all'Assistenza, Azienda USL Toscana centro;
A. Pompetti, Dirigente medico S.S Medicina preventiva ospedale SGD, Azienda USL Toscana centro;
E. Spadini, Infermiera SOS Vigilanza e Controllo Infezioni Correlate all'Assistenza, Azienda USL Toscana centro;
T. Faraoni, Dirigente medico SOS Ecomagement Firenze ed Empoli, Azienda USL Toscana centro;

Parole chiave: colonizzato, infetto, ospedale, malattie infettive, isolamento, precauzioni, sorveglianze speciali, infezioni, assistenza

INDICE

1. Premessa 3
2. Scopo/ obiettivi 3
3. Campo di applicazione 3
4. Responsabilità e descrizione delle attività 3
4.1 Le misure di isolamento 3
4.1.1 Precauzioni standard 3
4.1.2 Precauzioni aggiuntive basate sulle modalità di trasmissione 8
4.2 Raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari 16
4.3 Flusso informativo delle malattie infettive 17
4.3.1 Classi di malattie infettive 17
4.3.2 Definizione di caso 19
4.4 Sorveglianze speciali 19
5.5 Tabella riassuntiva isolamento/precauzione aggiuntive per organismo/patologia 24
5. Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione 37
6. Monitoraggio e controllo 37
7. Revisione 37
8. Allegati 37
9. Riferimenti 37
10. Indice revisioni 40
11. Lista di diffusione 40

Copia conforme all'originale

1. PREMESSA

Nel panorama dei potenziali rischi per la sicurezza del paziente, attribuibili all'assistenza sanitaria, le complicanze infettive giocano un ruolo di primo piano, perché sono frequenti, hanno un elevato impatto clinico ed economico e perché sono evitabili con l'adozione di misure idonee.
Ci sono, infatti, conoscenze consolidate su pratiche evidence-based nell'assistenza al paziente, capaci di ridurre significativamente il rischio di contrarre un'infezione durante l'assistenza sanitaria.
Esistono numerosi riferimenti accreditati sui quali basarsi per definire protocolli e procedure in grado di promuovere la sicurezza del paziente.
Tale procedura vuole essere un utile riferimento e uno strumento di lavoro che permetta di aumentare la percezione del problema negli operatori sanitari, di garantire il contenimento della diffusione delle malattie infettive e di istituire un percorso idoneo e istituzionale del flusso informativo.

2. SCOPO/ OBIETTIVI

- *Prevenire la trasmissione di malattie infettive;*
- *Tutelare l'utente e l'operatore sanitario;*
- *Rendere omogeneo il comportamento degli operatori sanitari in corso di patologia infettiva;*
- *Fornire indicazioni sul flusso informativo delle malattie infettive;*

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

- *Tutto il personale sanitario e tecnico delle degenze e dei servizi che viene a contatto con gli utenti;*
- *Tutto il personale dipendente di ditte appaltatrici che forniscono servizi;*

4. RESPONSABILITÀ E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

4.1 LE MISURE DI ISOLAMENTO

Per ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi in ospedale, sono implementate una serie di misure e precauzioni che costituiscono i fondamenti delle misure di isolamento: precauzioni standard e precauzioni aggiuntive basate sulle modalità di trasmissione.

4.1.1 PRECAUZIONI STANDARD

	***APPLICAZIONE*** *Da adottare sempre, nell'assistenza di tutti i pazienti indipendentemente dalla presenza di uno stato infettivo.*
	IGIENE DELLE MANI • *Lavare le mani con acqua e sapone o con antisettico immediatamente e accuratamente quando si verifica un accidentale contatto con il sangue, fluidi corporei, secreti, escreti e oggetti contaminati, anche se l'operatore indossa i guanti;*

copia conforme all'originale



- *Utilizzare preferibilmente il gel alcolico per l'igiene delle mani in tutte le altre situazioni cliniche descritte di seguito:*

  - prima e dopo l'assistenza diretta;

  - prima di utilizzare un dispositivo invasivo, indipendentemente dall'uso dei guanti;

  - dopo il contatto con fluidi o escrezioni corporee, mucosa o cute non integra, o medicazioni della ferita;

  - tra una procedura assistenziale e l'altra, anche se eseguite sullo stesso paziente;

  - quando si passa da un sito sporco a un sito pulito durante l'assistenza ad uno stesso paziente;

  - al termine dell'assistenza prestata ai pazienti, anche se si sono usati i guanti;

  - dopo il contatto con oggetti inanimati (comprese le apparecchiature medicali) nella zona paziente;

  - prima di indossare i guanti;

  - dopo la rimozione dei guanti;

- *Prevenire e curare screpolature, abrasioni e piccole ferite della cute;*

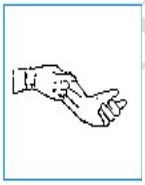
- *Mantenere le unghie corte (≤ 5mm), pulite e prive di smalto;*

- *Non indossare anelli, bracciali, orologi e altri monili quando si presta assistenza al paziente;*

- *Effettuare il lavaggio antisettico delle mani:*

  - *prima di eseguire procedure invasive sul paziente;*
  - *dopo aver toccato una qualsiasi fonte che può essere contaminata con patogeni e in specifiche circostanze (es. controllo di epidemie, infezioni permanentemente endemiche);*

(Allegato 1: Corretta vestizione e svestizione dei DPI)



GUANTI

I guanti NON rappresentano misura sostitutiva all'igiene delle mani

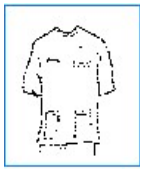
- *Effettuare l'igiene delle mani prima di indossare i guanti;*

- *Indossare guanti della misura adeguata e del tipo idoneo alla prestazione da effettuare;*

- *Indossare i guanti prima di venire in contatto con: sangue, fluidi corporei, secreti, escreti, mucose, cute non intatta dei pazienti e oggetti contaminati;*

- *Sostituire i guanti tra un paziente e l'altro;*

Copia conforme all'originale

	• Sostituire i guanti durante l'assistenza sullo stesso paziente, se si passa da una zona contaminata ad un'altra parte del corpo; *• Rimuovere i guanti quando si rompono o si verifica una puntura o una lacerazione;* *• Rimuovere prontamente i guanti dopo l'uso e lavare sempre le mani;* *• Eliminare i guanti visibilmente contaminati nel contenitore dei rifiuti infetti;* *• Rimuovere i guanti prima di effettuare qualunque altra azione non correlata all'assistenza;* *(Allegato 1: Corretta vestizione e svestizione dei DPI)*
	***MASCHERINE CON O SENZA VISIERA – OCCHIALI PROTETTIVI*** *• Utilizzare la mascherina chirurgica, la mascherina con visiera e/o gli occhiali protettivi per proteggere le mucose di occhi, naso e bocca durante l'esecuzione di procedure che possono generare droplet e/o schizzi di sangue o di altri liquidi biologici, come ad esempio, prelievi, procedure di aspirazione di liquidi biologici, broncoscopie;* *• Selezionare maschere, occhiali, visiere o combinazioni di essi in base al tipo di assistenza da effettuare;* *• Utilizzare la mascherina con o senza visiera una sola volta (monouso)ed eliminarla nel contenitore dei rifiuti infetti;* *• Ricondizionare i DPI pluriuso secondo le indicazioni del fabbricante;* *(Allegato 1: Corretta vestizione e svestizione dei DPI)*
	***CAMICI E INDUMENTI PROTETTIVI*** *• Indossare i camici per proteggere la cute e prevenire l'imbrattamento degli abiti durante l'esecuzione di procedure che possono determinare schizzi di sangue o di altri liquidi biologici;* *• Indossare camici idrorepellenti se si prevedono grosse contaminazioni;* *• Rimuovere i camici al termine dell'attività assistenziale;* *• Smaltirli nei contenitori per rifiuti potenzialmente infetti;* *• Eseguire igiene delle mani dopo aver tolto il camice e/o gli indumenti protettivi;* *(Allegato 1: Corretta vestizione e svestizione dei DPI)*
	***CONTROLLO DELLE INFEZIONI NELLA PRATICA DELLA PUNTURA LOMBARE*** *• Indossare la mascherina chirurgica ogni qual volta si esegue una puntura del canale spinale o dello spazio sub durale, sia per il posizionamento di un catetere, che per l'iniezione di sostanze, che per l'anestesia spinale o peridurale;*

Copia conforme all'originale



"IL GALATEO RESPIRATORIO" IGIENE RESPIRATORIA/ETICHETTA DELLA TOSSE

• Effettuare misure di controllo delle fonti d'infezione (ad es. coprire naso/bocca con un fazzoletto di carta quando si tossisce e smaltire immediatamente il fazzoletto usato, impiegare mascherine chirurgiche per il paziente che tossisce, se tollerate);

• Educare il paziente all'igiene delle mani;

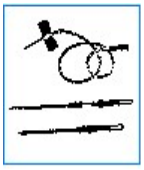
• Effettuare l'igiene delle mani dopo il contatto con secrezioni respiratorie;

• Rispettare quando possibile, una separazione spaziale, idealmente superiore al metro, delle persone con infezioni respiratorie rispetto alle altre, nelle aree di attesa comuni;

• Apporre cartelli, nella lingua/e appropriata/e per la popolazione assistita, con istruzioni per i pazienti e per i familiari o amici che li accompagnano;

• Educare il personale della struttura, i pazienti e i visitatori;

• Adottare le misure di contenimento della tosse fin dal primo approccio del paziente alla struttura sanitaria (triage, attesa DEA, ambulatori);



MANIPOLAZIONE DI STRUMENTI/OGGETTI TAGLIENTI

Adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, bisturi e altri dispositivi taglienti o pungenti durante il loro utilizzo, nelle fasi di decontaminazione, di sanificazione e di smaltimento.
Gli aghi e taglienti devono essere maneggiati con cura, per evitare lesioni durante il processo di smaltimento o re processing. Aghi e taglienti utilizzati devono essere smaltiti negli appositi contenitori, collocati in posizione comoda per il loro uso.



ATTREZZATURA PER L'IGIENE DEL PAZIENTE

Strumenti taglienti necessari per l'igiene del paziente, quali forbici, taglia-unghie, rasoi, spazzolini per unghie, devono essere personali.
Se non sono disponibili oggetti personali è necessario utilizzare preferibilmente materiale monouso.

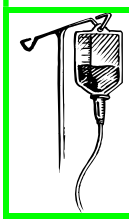


ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA AL PAZIENTE

• Manipolare con attenzione tutte le attrezzature impiegate per l'assistenza al paziente che risultano essere contaminate con sangue, liquidi corporei, secreti ed escreti per prevenire l'esposizione di cute, mucose e indumenti;

• Ricondizionare le attrezzature pluriuso, secondo le indicazioni del fabbricante e seguendo le istruzioni operative/procedure aziendali specifiche;

• Smaltire negli appositi contenitori i presidi sanitari monouso;



PRATICHE SICURE PER LE INIEZIONI

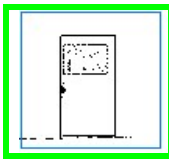
• Per evitare la contaminazione dei presidi sterili, usare tecniche asettiche;

• Utilizzare ogni presidio (siringa, ago, cannula, set infusione, ecc) per un solo paziente;

Copia conforme all'originale

	• Non somministrare a pazienti diversi soluzioni prelevate da fiale monouso, sacche o flaconi; *• Non mescolare le soluzioni residue per usi successivi;* *• Utilizzare quando possibile farmaci monodose per le soluzioni parenterali;* *• Sostituire ago e siringa tutte le volte che vengono prelevate soluzioni da preparazioni multi-dose;* *• Conservare ed eliminare le preparazioni multi dose secondo le indicazioni del produttore;*
	***BICCHIERI, TAZZE, PIATTI E POSATE*** *Non sono necessarie precauzioni particolari per piatti, bicchieri, tazze o utensili per il vitto.* *Per i pazienti affetti da patologie infettive quali CD e MDRO è necessario l'utilizzo di materiale monouso*
	***SMALTIMENTO RIFIUTI*** *Effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari seguendo le indicazioni le procedure aziendali e le normative di legge.*
	***SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE AMBIENTALE*** *• Verificare la corretta esecuzione della sanificazione ambientale eseguita da parte delle ditte appaltatrici, secondo i protocolli specifici (pulizie periodiche e/o ordinarie e/o alla dimissione del paziente);* *• Effettuare la decontaminazione in presenza di superfici contaminate da schizzi di sangue e materiale organico durante le attività assistenziali, utilizzando i kit di emergenza a disposizione;* *• Eseguire la sanificazione e disinfezione delle attrezzature elettromedicali e dispositivi medici, secondo le indicazioni del fabbricante;* *• Rispettare le indicazioni sulla corretta gestione dei detergenti e dei disinfettanti;*
	***TRASPORTO DEI PAZIENTI*** *• Smaltire correttamente la biancheria utilizzata e sanificare la barella una volta effettuato il trasporto del paziente;*
	***EDUCAZIONE SANITARIA AL PAZIENTE E AI VISITATORI*** *• Educare il paziente e i visitatori circa la necessità di utilizzare precauzioni finalizzate a prevenire la diffusione di microrganismi ad altre persone o all'ambiente;*
	COLLOCAZIONE DEL PAZIENTE *La corretta collocazione del paziente nella camera di degenza dipende dalle necessità cliniche e assistenziali. Se si sospetta la possibilità di trasmissione di un agente*

Copia conforme all'originale



infettivo, si rimanda alle indicazioni presenti nelle precauzioni aggiuntive, sulla base della via di trasmissione;

4.1.2 PRECAUZIONI AGGIUNTIVE BASATE SULLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Le precauzioni aggiuntive, diverse secondo la via di trasmissione, sono da adottare in tutti i casi di accertata o sospetta infezione da germi patogeni e/o di colonizzazione da microrganismo multi resistenti.
La durata dell'applicazione delle precauzioni aggiuntive varia secondo il profilo della malattia, ma deve essere prolungata per tutta la durata del ricovero in presenza di MDROs.
In caso di pazienti immunocompromessi, le precauzioni specifiche dovranno essere prolungate.
Se i microrganismi si trasmettono secondo più vie e/o in presenza di siti infetti multipli, le precauzioni aggiuntive devono essere applicate in combinazione.
Indipendentemente dalla tipologia delle precauzioni aggiuntive adottate, i DPI a disposizione degli operatori sanitari e dei visitatori devono essere collocati fuori dalla stanza di degenza
Indipendentemente dalla tipologia delle precauzioni aggiuntive adottate, i contenitori per i rifiuti a rischio infettivo e per la biancheria sporca devono essere collocati all'interno della stanza di degenza, in prossimità del punto di assistenza.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE	
Trasmissione per contatto HANDBORNE	*È la modalità di trasmissione più comune . La trasmissione per contatto può avvenire secondo due modalità:* *- CONTATTO DIRETTO : da un soggetto colonizzato o infetto ad un ospite suscettibile. Avviene quando si ha un reale contatto fisico fra sorgente e ospite;* *- CONTATTO INDIRETTO: comporta il contatto di un ospite recettivo con oggetti contaminati, usualmente inanimati, come strumenti, aghi, medicazioni o mani contaminate degli operatori sanitari o guanti non sostituiti tra paziente e paziente. Infatti è ormai noto che le mani del personale sanitario contribuiscano in maniera importante a questa modalità di trasmissione;*
Trasmissione per DROPLET	*La trasmissione avviene quando le goccioline dal tratto respiratorio dell'individuo infetto, sono inviate a breve distanza (1-2 m.) attraverso l'aria, e si depositano sulle congiuntive, le mucose nasali o la bocca dell'ospite suscettibile.* *Le goccioline sono generate dalla persona-sorgente in primo luogo attraverso la tosse, lo starnuto o parlando, oppure attraverso l'esecuzione di alcune procedure (intubazione o aspirazione endotracheale, rianimazione cardiopolmonare, ecc.).*
Trasmissione per via aerea AIRBORNE	*La trasmissione per via aerea avviene mediante la diffusione o di nuclei di goccioline o di piccole particelle di diametro tale da essere respirabili.* *Questi contengono agenti infettivi che rimangono tali nel tempo e distanza (ad esempio il Mycobacterium tuberculosis).* *I microrganismi possono essere dispersi su lunghe distanze dalle correnti d'aria e rimanere nell'aria a lungo, per esempio nella stanza di degenza ed essere inalati da ospiti suscettibili.*
Altre fonti di	*- **Trasmissione tramite veicoli o comuni fonti ambientali**: riguarda microrganismi trasmessi da oggetti contaminati come cibo, acqua, medicazioni, presidi ed attrezzature (ad esempio alimenti contaminati, acqua, o farmaci);*

Copia cartacea all'originale

trasmissione	- ***Trasmissione mediante vettori:*** *(zanzare, mosche, ratti e altri parassiti). Possono anche verificarsi in ambienti sanitari;* - ***Trasmissione verticale:*** *da madre a figlio, spesso in utero o per lo scambio accidentale di fluidi corporei solitamente nel periodo perinatale;*

Le tabelle sottostanti possono risultare ripetitive in alcuni contenuti. E' stata scelta questa modalità di editing per facilitare l'operatività del personale sanitario che all'occorrenza può estrapolare la tabella di interesse.

ISOLAMENTO DA CONTATTO HANDBORNE Precauzioni da adottare in aggiunta alle Precauzioni Standard	
	***APPLICAZIONE*** *Da adottare nei confronti di pazienti con sospetta o diagnosticata infezione da patogeni trasmissibili tramite contatto diretto e indiretto o colonizzazione da microrganismi con profilo di multi resistenza antibiotica (MDROs)*
	***IGIENE DELLE MANI*** *Si ricorda che nell'assistenza al paziente con microrganismi sporigeni (es. Clostridium difficile) l'igiene delle mani deve essere effettuata esclusivamente con sapone e acqua*
	***CAMICI*** *• Indossare un camice pulito (non sterile) ogni volta che ci si avvicina nella zona paziente;* *• Rimuovere il camice prima di lasciare il punto di assistenza ed effettuare immediatamente l'igiene delle mani;* *• Smaltire il camice nell'apposito contenitore per i rifiuti a rischio infettivo;* *• In caso di paziente con scabbia e pediculosi, è indicato l'uso della cuffia;*
	***COLLOCAZIONE DEL PAZIENTE*** *• Collocare il paziente preferibilmente in stanza singola con servizi igienici dedicati;* *• Considerare l'epidemiologia del microrganismo e la tipologia dei pazienti, prima di procedere alla collocazione del paziente, se la stanza singola non è disponibile;* *• Disporre più pazienti con lo stesso microrganismo nella stessa stanza, se la stanza singola non è disponibile (isolamento di coorte), purché non abbiano altre infezioni;* *• Effettuare l'isolamento "funzionale" se non è disponibile la camera singola e non è realizzabile la coorte;* *• Mantenere, nell'isolamento funzionale, la distanza minima di 1 metro fra il paziente infetto e gli altri pazienti;*

Copia conforme all'originale

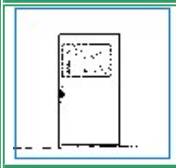
	• *In caso con stanze con tre o più posti letto, collocare il paziente all'estremità della stanza di degenza. Dove disponibile, utilizzare le tende di separazione;* • *Invitare il paziente deambulante a soggiornare il più a lungo possibile nella sua stanza;*
	***ATTREZZATURA PER L'ASSISTENZA AL PAZIENTE*** • *Utilizzare preferibilmente materiale monouso;* • *Assegnare dispositivi e articoli non critici (es. sfigmomanometro, fonendoscopio, termometro ecc) dedicati ad un solo paziente;* • *Assicurarsi che le attrezzature nelle immediate vicinanze del paziente e gli strumenti impiegati per l'assistenza e frequentemente toccati, siano regolarmente detersi e disinfettati;*
	***TRASPORTO DEL PAZIENTE*** • *Spostare il paziente dalla stanza di degenza solo se necessario;* • *<u>Se necessario il suo spostamento:</u>* *- Avvertire il personale del servizio in cui il paziente deve essere condotto del suo arrivo imminente e delle precauzioni da adottare;* *- Programmare le prestazioni a fine seduta;* *- Informare il personale addetto al trasporto (ditte in appalto) delle precauzioni da adottare;* *- Porre in atto e fare indossare al paziente appropriate misure di barriera (pannoloni, medicazioni impermeabili, ecc.) per ridurre la possibilità di contaminazione dell'ambiente e di trasmissione di microrganismi ad altri pazienti, personale o visitatori;* *- Smaltire correttamente la biancheria utilizzata per il trasporto;* *- Sanificare la barella una volta effettuato il trasporto del paziente con patologia infettiva;*
	SANIFICAZIONE AMBIENTALE • *Sanificare gli ambienti secondo i protocolli aziendali;* • *Registrare l'avvenuta esecuzione dell'intervento attraverso la modulistica in uso;* • *Programmare la sanificazione dei locali dei servizi dove ha stazionato il paziente, attraverso intervento specifico;*
	***EDUCAZIONE SANITARIA*** • *Istruire il paziente sulle norme igieniche da osservare per prevenire la diffusione di microrganismi ad altri pazienti o all'ambiente, es. igiene delle mani dopo ogni contatto con materiale potenzialmente contaminato (es. fluidi corporei, effetti letterecci);*

Copia conforme all'originale

	• *Limitare l'accesso ai visitatori ed informarli sulle norme igieniche da osservare durante la visita al paziente (uso di DPI, lavaggio antisettico delle mani dopo il contatto con il paziente) e nella gestione dei suoi effetti personali (es. trasporto e lavaggio a domicilio della biancheria personale);*
	***SOMMINISTRAZIONE DEL VITTO*** *Per la somministrazione del vitto è rilevante l'utilizzo di stoviglie monouso da gettare subito dopo la consumazione del pasto.* *Una volta consumato il pasto, le vaschette contenenti il cibo devono essere smaltite con i rifiuti infetti.*
	BIANCHERIA E LAVANDERIA *Tutti gli effetti letterecci, una volta rimossi indossando guanti di protezione, devono essere inviati alla lavanderia negli appositi sacchi per biancheria a rischio infettivo (idrosolubili) e, successivamente, nel sacco impermeabile.*

ISOLAMENTO DA DROPLET **Precauzioni da adottare in aggiunta alle Precauzioni Standard**	
	***APPLICAZIONE*** *Da adottare nei confronti di pazienti con sospetta o diagnosticata infezione da patogeni trasmissibili tramite droplet*
	IGIENE DELLE MANI *Vedi paragrafo "IGIENE MANI" nel capitolo Precauzioni standard.*
	
	***GUANTI*** • *Effettuare l'igiene delle mani prima di indossare i guanti;* • *Indossare guanti puliti (non sterili) ogni volta ci si avvicina alla zona paziente;* • *Rimuovere i guanti prima di lasciare la zona paziente ed effettuare immediatamente l'igiene delle mani;* • *Smaltire i guanti nell'apposito contenitore per i rifiuti a rischio infettivo;*

Copia conforme all'originale

	***PROTEZIONE RESPIRATORIA*** *• Indossare la mascherina chirurgica quando ci si avvicina a meno di un metro dal paziente;*
	***CAMICI E INDUMENTI PROTETTIVI*** *Nel caso di manovre che possono produrre aerosol (es bronco aspirazione, prelievo di escreato), indossare un camice monouso (non sterile) e occhiali protettivi/visiera e mascherina chirurgica;*
	COLLOCAZIONE DEL PAZIENTE *• Collocare il paziente preferibilmente in stanza singola con servizi igienici dedicati;* *• Considerare l'epidemiologia del microrganismo e la tipologia dei pazienti, prima di procedere alla collocazione del paziente, se la stanza singola non è disponibile;* *• Disporre più pazienti con la stesso microrganismo nella stessa stanza, se la stanza singola non è disponibile (isolamento di coorte), purché non abbiano altre infezioni;* *• Effettuare l'isolamento "funzionale" se non è disponibile la camera singola e non è realizzabile la coorte;* *• Mantenere, nell'isolamento funzionale, la distanza minima di 1 metro fra il paziente infetto e gli altri pazienti.* *In caso con stanze con tre o più posti letto, collocare il paziente all'estremità della stanza di degenza. Dove disponibile, utilizzare le tende di separazione;* *• Invitare il paziente deambulante a soggiornare il più a lungo possibile nella sua stanza e, se deve uscire, fargli indossare una mascherina chirurgica;*
	
	***ATTREZZATURA PER L'ASSISTENZA AL PAZIENTE*** *• Utilizzare preferibilmente materiale monouso;* *• Assegnare, quando è possibile, dispositivi e articoli non critici (es. sfigmomanometro, fonendoscopio, termometro ecc) dedicati ad un solo paziente;* *• Assicurarsi che le attrezzature nelle immediate vicinanze del paziente e gli strumenti impiegati per l'assistenza e frequentemente toccati, siano regolarmente detersi e disinfettati;*

copia conforme all'originale



TRASPORTO DEL PAZIENTE

• Spostare il paziente dalla stanza di degenza solo se necessario;

• Nel caso in cui si renda comunque indispensabile il suo spostamento:

- *Porre in atto e fare indossare al paziente appropriate misure di barriera (mascherina chirurgica) per ridurre la possibilità di contaminazione dell'ambiente e di trasmissione di microrganismi ad altri pazienti, personale o visitatori;*
- *Avvertire il personale del servizio in cui il paziente deve essere condotto del suo arrivo imminente e delle precauzioni da adottare;*
- *Informare il personale addetto al trasporto (ditte in appalto) delle precauzioni da adottare;*
- *Informare i pazienti circa i modi in cui possono aiutare a prevenire la trasmissione ad altri dei loro agenti patogeni;*
- *Smaltire correttamente la biancheria utilizzata;*
- *Sanificare la barella una volta effettuato il trasporto del paziente con patologia infettiva;*



EDUCAZIONE SANITARIA

• Istruire il paziente sulle norme igieniche da osservare per prevenire la diffusione di microrganismi ad altri pazienti o all'ambiente, esempio:

- Igiene delle mani dopo ogni contatto con materiale potenzialmente contaminato (fazzoletti, effetti letterecci, superfici, ecc.);

- coprirsi il naso o la bocca durante gli accessi di tosse (vedi Precauzione Standard "Galateo respiratorio – Igiene Respiratoria/etichetta della tosse");

• Limitare l'accesso ai visitatori ed informarli sulle norme igieniche da osservare durante la visita al paziente (uso di mascherina chirurgica, igiene delle mani dopo il contatto con il paziente) e nella gestione dei suoi effetti personali (es. trasporto e lavaggio a domicilio della biancheria personale);t



SOMMINISTRAZIONE DEL VITTO

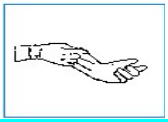
Per la somministrazione del vitto è rilevante l'utilizzo di stoviglie monouso da gettare subito dopo la consumazione del pasto.

BIANCHERIA E LAVANDERIA

Tutti gli effetti letterecci, una volta rimossi indossando guanti di protezione, devono essere inviati alla lavanderia negli appositi sacchi per biancheria a rischio infettivo (idrosolubili) e, successivamente, nel sacco impermeabile.

ISOLAMENTO AEREO
AIRBORNE

Copia conforme all'originale

Precauzioni da adottare in aggiunta alle Precauzioni Standard	
	***APPLICAZIONE*** *Da adottare nei confronti di pazienti con sospetta o diagnosticata infezione da patogeni trasmissibili tramite via aerea*
	***COLLOCAZIONE DEL PAZIENTE*** • *In assenza di locali da isolamento con requisiti specifici:* - *Collocare il paziente in una stanza singola con servizi igienici dedicati;* - *Aprire le finestre tutte le volte che è possibile, per favorire i ricambi d'aria;* - *Far sì che il paziente deambulante permanga nella sua stanza, e mantenere la porta della camera sempre chiusa;* - *Far indossare al paziente la mascherina chirurgica;* - *Deve essere previsto il trasferimento del paziente verso strutture con ambienti adeguati nel minor tempo possibile;* • In caso di sospetta o accertata TBC polmonare collocare il paziente in stanze con ventilazione a pressione negativa e opportuno ricambio dell'aria (da 6 a 12 ricambi ora), con assenza di ricircolo nelle aree circostanti dell'aria estratta, se non preventivamente trattata con filtri ad alta efficienza (filtri HEPA);
	***PROTEZIONE RESPIRATORIA*** • *Indossare mascherina di protezione respiratoria di efficienza almeno FFP2 quando si accede alla stanza per le normali attività assistenziali;* • *Indossare filtrante facciale di classe FFP3 per lo svolgimento di procedure che provocano tosse o generano aerosol in ogni patologia trasmissibile per via aerea;* • *Far indossare la mascherina chirurgica al paziente;*
	***ASSISTENZA AL PAZIENTE*** • *Il personale di assistenza al paziente deve essere circoscritto nel numero;* • *Utilizzare preferibilmente materiale monouso;* • *Assegnare dispositivi e articoli non critici (es. sfigmomanometro, fonendoscopio, termometro, ecc) dedicati ad un solo paziente;* • *Assicurarsi che le attrezzature nelle immediate vicinanze del paziente e gli strumenti impiegati per l'assistenza e frequentemente toccati, siano regolarmente detersi e disinfettati;*
	***GUANTI*** • *Effettuare l'igiene delle mani prima di indossare i guanti;*

Copia conforme all'originale

	• *Indossare guanti puliti (non sterili) ogni volta che ci si avvicina nel punto di assistenza;* • *Rimuovere i guanti prima di lasciare il punto di assistenza ed effettuare immediatamente l'igiene delle mani;* • *Smaltire i guanti nell'apposito contenitore per i rifiuti a rischio infettivo;*
	***TRASPORTO DEL PAZIENTE*** • *Spostare il paziente dalla stanza di degenza solo se indispensabile;* • *Nel caso in cui si renda comunque indispensabile il suo spostamento:* • *Fare indossare al paziente appropriate misure di barriera (mascherina chirurgica per tutto il tempo che rimane fuori dalla camera) per ridurre la possibilità di contaminazione dell'ambiente e di trasmissione di microrganismi ad altri pazienti, personale o visitatori;* • *Avvertire il personale del servizio in cui il paziente deve essere condotto del suo arrivo imminente e delle precauzioni da adottare;* • *Informare il personale addetto al trasporto (ditte in appalto) delle precauzioni da adottare;* • *Informare i pazienti circa i modi in cui possono aiutare a prevenire la trasmissione ad altri dei loro agenti patogeni;* • *Assicurarsi che vengano mantenute tutte le precauzioni necessarie ad evitare la trasmissione di microrganismi ad altri pazienti e la contaminazione ambientale e delle attrezzature;* • *Smaltire correttamente la biancheria utilizzata;* • *Sanificare la barella una volta effettuato il trasporto del paziente con patologia infettiva;* • *Per il personale delle ditte in appalto che effettuano il trasporto dei pazienti, si raccomanda di attenersi alle procedure aziendali;*
	***EDUCAZIONE SANITARIA*** • *Istruire il paziente sulle norme igieniche da osservare per prevenire la diffusione di microrganismi ad altri pazienti o all'ambiente, esempio:* *- Igiene delle mani dopo ogni contatto con materiale potenzialmente contaminato (fazzoletti, effetti letterecci, superfici);* *- coprirsi il naso o la bocca durante gli accessi di tosse (vedi Precauzione Standard "Galateo respiratorio – Igiene Respiratoria/etichetta della tosse");* • *Limitare l'accesso ai visitatori ed informarli sulle norme igieniche da osservare durante la visita al paziente (uso di filtrante facciale FFP2, igiene delle mani dopo il contatto con il paziente) e nella gestione dei suoi effetti personali (es. trasporto e lavaggio a domicilio della biancheria personale);*

Copia conforme all'originale

	***SOMMINISTRAZIONE DEL VITTO*** *Per la somministrazione del vitto è rilevante l'utilizzo di stoviglie monouso da gettare subito dopo la consumazione del pasto.* *Una volta consumato il pasto, le vaschette contenenti il cibo devono essere smaltite con i rifiuti infetti.*
	BIANCHERIA E LAVANDERIA *Tutti gli effetti letterecci, una volta rimossi indossando guanti di protezione, devono essere inviati alla lavanderia negli appositi sacchi per biancheria a rischio infettivo (idrosolubili) e, successivamente, nel sacco impermeabile.*

4.2 RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI

Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti in ambienti di isolamento/prodotti dalla cura di pazienti in isolamento è necessario attenersi alle procedure aziendali e di presidio; alcune indicazioni sono state già inserite negli schemi precedenti.

Nello specifico, sono da considerarsi rifiuti a rischio infettivo (C.E.R. 18.01.03), "rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti , applicando precauzioni particolari per evitare infezioni" :

a) tutti i rifiuti provenienti da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussista un rischio di trasmissione biologica aerea;

b) tutti i presidi e dispositivi utilizzati e da smaltire che provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati, o siano contaminati da sangue;
Il confezionamento di detti rifiuti deve avvenire nell'apposito sacco rosso o giallo con contenitore esterno rigido a chiusura ermetica, apponendo sul coperchio data di confezionamento e reparto/servizio di provenienza;

c) i rifiuti taglienti (aghi, lame, bisturi monouso ecc..) devono essere raccolti negli appositi contenitori rigidi a chiusura ermetica e per lo smaltimento confezionati come gli altri rifiuti C.E.R. 18.01.03;

I rifiuti sanitari assimilati agli urbani, ad eccezione del caso di trasmissione biologica per via aerea, devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità utilizzate negli ambienti sanitari non di isolamento, come indicato nelle procedure aziendali e di presidio .

Al fine di garantire la sicurezza degli operatori è necessario osservare le seguenti norme comportamentali:

- *Sistemare i contenitori per i rifiuti in posizione comoda, sicura e vicino al luogo posto dove devono essere utilizzati;*
- *Evitare, nel modo più assoluto, di prelevare e/o manipolare materiale dai contenitori per i rifiuti.*
- *Utilizzare idonei dispositivi per la protezione della cute e delle mucose (DPI) durante la fase di raccolta e di confezionamento dei rifiuti;*
- *Trasportare e movimentare solo contenitori correttamente chiusi, al fine di evitare accidentali fuoriuscite e spargimento di rifiuti;*
- *Evitare di trascinare i contenitori dei rifiuti, di appoggiarli al corpo e di effettuare qualsiasi altra manovra che possa pregiudicare la propria e altrui sicurezza;*

Copia conforme all'originale

4.3 FLUSSO INFORMATIVO DELLE MALATTIE INFETTIVE

L'attuale sistema di sorveglianza delle malattie infettive, definito dal D.M. 15 dicembre 1990, prevede una suddivisione delle malattie infettive in 5 classi, caratterizzate da tempi e modalità di notifica diversi e proporzionali alla rilevanza della classe di appartenenza. (D.M. 15/12/90).

4.3.1 CLASSI DI MALATTIE INFETTIVE

Classe I

Malattie soggette a segnalazione immediata perché rientrano nel regolamento sanitario internazionale o perché rivestono particolare interesse.

Tempo di segnalazione all' U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione competente per territorio: immediata

Malattie: colera, botulismo,febbre gialla, febbre ricorrente epidemica, influenza con isolamento virale, febbri emorragiche virali (febbre di Lassa, Marburg, Ebola), rabbia, peste, tetano, poliomielite, trichinosi, tifo esantematico, difterite, malattia di Creutzfeldt-Jakob, la variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, la sindrome di Gerstmann-Straussler-Scheinker, l'insonnia familiare letale, ed eventuali sindromi ad esse correlate.

Classe II

Malattie rilevanti perché ad elevata frequenza e/o passibili di intervento di controllo.

Tempo di segnalazione all' U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione competente per territorio: 48 ore, ad eccezione di meningite meningococcica o meningite batterica/sepsi con sospetto di meningococcica o malattia invasiva meningococcica per la quale la segnalazione deve essere immediata per poter permettere una precoce profilassi sui contatti.

Malattie: Blenorragia, meningite ed encefalite acuta virale, brucellosi, meningite meningococcica, diarree infettive non da salmonelle, clostridium difficile, morbillo, epatite virale A, parotite, epatite virale B, pertosse, epatite virale non A no B, rickettsiosi diversa da tifo esantematico, epatite virale non specificata, rosolia, febbre tifoidea, salmonellosi non tifoidea, legionellosi, scarlattina, leishmaniosi cutanea, sifilide con manifestazioni contagiose, leishmaniosi viscerale, tularemia, leptospirosi, varicella, listeriosi.

Classe III

Malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni.

Tempo di segnalazione all'U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione competente per territorio: 48 ore

Malattie: Aids, micobatteriosi non tubercolare, lebbra, tubercolosi, malaria.

Classe IV

Malattie per le quali alla segnalazione del medico deve seguire la segnalazione dell'Az. USL solo quando si verificano focolai epidemici.

Tempo di segnalazione all' U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione competente per territorio: 24 ore

Malattie: Dermatofitosi (tigna), pediculosi, scabbia, infezioni, tossinfezioni, ed infestazioni di origine alimentare.

Classe V

Malattie infettive e diffusive non comprese nelle classi precedenti, nonché zoonosi di cui al D.P.R.

Copia conforme all'originale

*320/54, nonché per i germi multi resistenti. Ove tali malattie assumano le caratteristiche di focolaio epidemico, verranno segnalate con le modalità previste dalla **classe IV**.*

La differente rilevanza delle malattie infettive è stata attribuita sulla base:

- *Dell'elevata gravità (in termini di letalità, costo sociale, impatto sanitario ed economico);*
- *Dell'estrema rarità attesa;*
- *Dell'interesse sul piano nazionale ed internazionale;*
- *Delle possibilità di intervento con azioni di profilassi e/o terapia, e/o educazione sanitaria;*

Questo sistema di notifica è da considerarsi comunque passibile di modifica a breve tempo poiché in fase di adeguamento a quello di sorveglianza europea che abolisce le classi e definisce meglio i criteri di segnalazione. Attualmente la notifica effettuata dal medico per ogni caso di malattia accertata o sospetta, avviene tramite un modulo unico (Notifica obbligatoria di Malattia infettiva e diffusiva).
Per le notifiche di sifilide e blenorragia vanno omessi i campi nome e cognome ma compilati gli altri campi. Il medico è comunque tenuto a segnalare ogni malattia infettiva e una fotocopia della notifica deve rimanere in cartella.
La notifica, una volta compilata deve essere trasmessa alla DSPO che provvede ad inviarla all' Area Igiene Pubblica e Nutrizione competente per territorio. Questa, a sua volta, provvede a compilare un'apposita scheda a seconda della classe di appartenenza della malattia.
Il modulo di notifica dovrà essere inviato a mezzo posta elettronica utilizzando i seguenti indirizzi:

- *malattieinfettive.firenze@asf.toscana.it per il P.O. di Santa Maria Nuova e San Giovanni di Dio;*
- *malattieinfettive.sudest@asf.toscana.it per il P.O. di Santa Maria Annunziata e Serristori;*
- *malattieinfettive.mugello@asf.toscana.it per il P.O. di Borgo San Lorenzo;*
- *malattieinfettive.nordovest@asf.toscana.it anche se non è presente un ospedale di riferimento dell'azienda, è da tenersi presente per l'invio delle notifiche dei residenti in questo territorio;*
- *notificheigiene@usl4.toscana.it per il P.O di Prato;*
- *segnalazioni.malattieinfettive.pistoia@uslcentro.toscana.it per il P.O di Pistoia;*
- *segnalazioni.malattieinfettive.pescia@uslcentro.toscana.it per il P.O di Pescia;*
- *malinfempoli@usl11.toscana.it per il P.O San Giuseppe di Empoli;*

Per le notifiche e/o comunicazioni riguardo malattie infettive urgenti (es. malattia meningococcica, tossinfezione alimentare, malattie di classe I) si raccomanda anche un contatto telefonico secondo apposita istruzione operativa/procedura redatta secondo modalità dell'ex Ausl di appartenza (Allegato 2). Sempre per malattie infettive urgenti (come sopra indicate) qualora vi fosse la necessità di effettuare variazioni o integrazioni alla notifica si deve procedere con la stessa modalità di trasmissione, ad eccezione della prima classe, la cui notifica (anche telefonica) deve avvenire entro le 12 ore dal sospetto di malattia; l'invio delle notifiche di classe II, III (TBC) e IV, da parte dell' U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione ha cadenza mensile.
La Regione a sua volta invia all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e al Ministero della Salute i modelli individuali, e all'ISTAT i riepiloghi mensili suddivisi per provincia, fasce di età e sesso.
A questo sistema fa eccezione l'AIDS, notificato direttamente all'Assessorato regionale alla Sanità e all'ISS dal medico che accerta il caso.

Copia conforme all'originale

4.3.2 DEFINIZIONE DI CASO

Definizione di caso ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 159/46 del 18/06/2008).

I casi vengono classificati come "possibile", "probabile" e "confermato". I periodi di incubazione per le singole malattie sono dettagliati nelle informazioni aggiuntive riportate nel documento stesso.

Caso possibile: soddisfa i criteri clinici descritti nella definizione di caso per la singola patologia ma per il quale non esistono prove epidemiologiche o di laboratorio della malattia in questione.

Caso probabile: soddisfa i criteri clinici e presenta correlazione epidemiologica come descritto nella definizione di caso per la singola patologia

Caso confermato: caso confermato in laboratorio. Si suddivide in 3 sottogruppi: a) caso confermato in laboratorio e con criteri clinici; b) caso confermato in laboratorio e con criteri clinici sconosciuti (manca l'informazione sul criterio clinico); c) caso confermato in laboratorio e senza criteri clinici.

Criteri clinici: comprendono segni e sintomi comuni e pertinenti della malattia che singolarmente o in associazione costituiscono un quadro clinico chiaro e indicativo della patologia.

Criteri di laboratorio: elenco di metodi di laboratorio utilizzati a conferma di un caso.

Criteri epidemiologici e correlazione epidemiologica: i criteri epidemiologici si considerano soddisfatti quando è possibile stabilire una correlazione epidemiologica. La correlazione epidemiologica, durante il periodo di incubazione, varia a seconda della modalità di trasmissione (interumana, da animale a uomo, esposizione ad una fonte comune, esposizione ad alimenti o acqua da bere contaminata, esposizione ambientale, esposizione in laboratorio). Una persona può essere considerata epidemiologicamente correlata ad un caso confermato se almeno un caso nella catena di trasmissione è stato confermato in laboratorio. Nel caso di un focolaio a trasmissione feco-orale o aerea non è necessario stabilire la catena di trasmissione per considerare un caso come epidemiologicamente correlato.

4.4 SORVEGLIANZE SPECIALI

Per alcune patologie, qui di seguito riportate, il Ministero della Salute, ha ritenuto necessario avviare delle sorveglianze specifiche, per le quali è necessario compilare le apposite schede.

Sorveglianza AIDS e le nuove sieropositività

*I casi di AIDS conclamata **non devono essere notificati** con il modulo unico, ma bensì con **apposita modulistica** reperibile presso:*

- ***U.O Malattie Infettive OSMA (Firenze);***
- ***U.O Malattie infettive SAN GIUSEPPE (Empoli);***
- ***U.O Malattie Infettive Santo Stefano (Prato);***
- ***U.O Malattie infettive San Jacopo (Pistoia);***

Copia conforme all'originale

Sorveglianza della Legionellosi

Nei casi di sospetta legionellosi è obbligatorio, da parte del medico che pone la diagnosi la compilazione della speciale "Scheda di sorveglianza della legionellosi"; che deve essere trasmessa, a cura della Direzione Sanitaria di PO, alla U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione competente per territorio.

Questa scheda non sostituisce il modello unico di notifica che deve essere comunque compilato.

Sorveglianza della Malaria

Il medico che fa diagnosi di Malaria deve compilare la speciale "Scheda di sorveglianza per Malaria"; che deve essere trasmessa, alla Direzione Sanitaria di PO, accompagnata da vetrino.

La Direzione Sanitaria/Medica del Presidio Ospedaliero o il Centro Clinico dovrà dare comunicazione del caso tramite l'invio della scheda di sorveglianza contestualmente a:

- *Ministero della Salute - Direzione Generale Prevenzione Sanitaria, Ufficio 5 - Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale, Viale Giorgio Ribotta, 5, Roma-00144*
  Recapiti telefonici 06 5994 3905; fax: 06 5994 3096. Indirizzo di posta elettronica: malinf@sanita.it
- *Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299, 00161-Roma,* ***specificando nell'intestazione "Notifica per malaria"*** *e allegando anche i preparati emoscopici per gli accertamenti di competenza (conferma di diagnosi)*
  Recapiti telefonici (5 interni) 06.49902301/2303/3108/2373/2309; Fax: 06.49903561. Indirizzo di posta elettronica: sorveglianza.malaria@iss.it
- *Assessorato Regionale alla Sanità;*
- *U.F Igiene Pubblica e Nutrizione di zona*

Nota bene: *La procedura di segnalazione per i casi importati, per i casi di decesso e, come già detto, per i casi di recidiva e recrudescenza va eseguita entro 5 giorni (48 ore più 72 ore) dalla diagnosi effettuata da parte del Presidio Ospedaliero.*

Nell'evenienza di un caso di un caso di malaria confermato che si presuma autoctono, anche indotto, la procedura di segnalazione va eseguita entro 24 ore dalla diagnosi, per vie brevi (telefono, fax, posta elettronica), al fine di attivare rapidamente l'inchiesta epidemiologica.

La scheda di segnalazione non sostituisce il modello unico di notifica che deve essere comunque compilato ed inviato all' U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione competente per territori.

Sorveglianza meningite batterica/sepsi/malattia batterica invasiva

Il medico che fa diagnosi di meningite batterica/ sepsi/malattia batterica invasiva deve compilare la scheda di "Sorveglianza delle meningiti batteriche e delle malattie invasive da meningococco, pneumococco, emofilo"; che deve essere trasmessa, a cura della Direzione Sanitaria di PO, alla U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione competente per territorio.

Questa scheda non sostituisce il modello unico di notifica che deve essere comunque compilato.

In base alle indicazioni emanate dalla Regione Toscana nel 2015, si raccomanda che, ove le condizioni del paziente lo permettano, vengano prelevate due aliquote di liquor delle quali una deve essere inviata al Laboratorio di Immunologia dell'AOU Meyer (Prof. Chiara Azzari) unitamente ad un campione di sangue in EDTA (tappo viola).

L'altro campione di liquor seguirà le usuali procedure per l'accertamento microbiologico Nel caso in cui non sia stato possibile prelevare due aliquote di liquor, si chiede di inviare comunque il residuo dell'unico campione disponibile, al Laboratorio di immunologia dell'AOU Meyer, sempre accompagnato dalla provetta di sangue. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la rachicentesi, si raccomanda di inviare comunque una provetta di sangue al Laboratorio di Immunologia dell'AOU Meyer.

Copia conforme all'originale

Sorveglianza Malattia di Creutzfeldt-Jakob

Il medico che fa diagnosi di Malattia di Creutzfeldt-Jakob deve compilare l'apposita scheda di "Sorveglianza di Malattia di Creutzfeldt-Jakob"; attraverso invio immediato, deve essere trasmessa, a cura della Direzione Sanitaria di PO, alla U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione competente per territorio.

Questa scheda non sostituisce il modello unico di notifica che deve essere comunque compilato.

Sorveglianza della Tubercolosi e delle Micobatteriosi

Il medico che fa diagnosi di Tubercolosi o di Micobatteriosi deve compilare la speciale "Scheda di Notifica per TBC o Micobatteriosi"); che deve essere trasmessa, a cura della Direzione Sanitaria di PO, alla U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione. Questa scheda può sostituire il modello unico di notifica.

Deve essere compilato da parte del clinico che effettua diagnosi, anche la "Scheda di Sorveglianza dell'esito di Trattamento nella TBC polmonare" ed inviata all'U.F Igiene Pubblica e Nutrizione.

Sorveglianza della Rosolia in gravidanza

Il medico che fa diagnosi di rosolia in gravidanza deve compilare la speciale "Scheda di sorveglianza per rosolia in gravidanza"; che deve essere trasmessa entro due giorni, a cura della Direzione Sanitaria di PO, alla U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione competente per territorio.

Questa scheda non sostituisce il modello unico di notifica che deve essere comunque compilato.

Sorveglianza della Rosolia congenita

Il medico che fa diagnosi di rosolia congenita deve compilare la speciale "Scheda di sorveglianza per rosolia congenita"; che deve essere trasmessa entro due giorni, a cura della Direzione Sanitaria di PO, alla U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione competente per territorio.

Questa scheda non sostituisce il modello unico di notifica che deve comunque essere compilato.

Sorveglianza della Rosolia

Il medico che fa diagnosi di rosolia deve segnalare entro 12 ore, per telefono, fax o posta elettronica, ogni caso sospetto di morbillo e di rosolia alla ASL e compilare la speciale "Scheda di Sorveglianza Integrata MORBILLO–ROSOLIA"; che deve essere trasmessa a cura della Direzione Sanitaria di PO, alla U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione competente per territorio.

Questa scheda non sostituisce il modello unico di notifica che deve essere comunque compilato.

Sorveglianza del Morbillo

Il medico che fa diagnosi di morbillo deve segnalare entro 12 ore, per telefono, fax o posta elettronica, ogni caso sospetto di morbillo e di rosolia alla ASL e compilare la speciale Scheda di Sorveglianza Integrata MORBILLO-ROSOLIA"; che deve essere trasmessa, a cura della Direzione Sanitaria di PO, alla U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione competente per territorio.

I medici dell'area sanitaria interessata devono raccogliere, se possibile (in base alla disponibilità del kit per il prelievo presso il reparto), campioni biologici (sangue, urine, saliva, tampone faringeo) per la conferma di laboratorio dei casi sospetti durante il primo contatto con il paziente, come da istruzioni.

Questa scheda non sostituisce il modello unico di notifica che deve essere comunque compilato.

Copia conforme all'originale

NOTA BENE:
La corretta scelta dei tempi di prelievo dei campioni biologici rispetto all'insorgenza delle manifestazioni cliniche è importante per l'interpretazione dei risultati e per giungere ad una conferma della diagnosi. Dopo il prelievo, i campioni vanno inviati al laboratorio il più rapidamente possibile.
La soluzione ideale è effettuare contemporaneamente sia il prelievo di sangue e saliva per la diagnosi sierologica sia il prelievo di urine per l'isolamento virale. Questo è possibile se i prelievi vengono tutti effettuati tra il 4° ed il 7° giorno dall'esordio dell'esantema (per i casi sospetti di morbillo o rosolia), o della tumefazione parotidea (per i casi sospetti di parotite epidemica).

Sorveglianza di Chikungunya, Dengue e Zika
Il medico che fa diagnosi deve compilare la speciale "Scheda di notifica e sorveglianza di arbovirosi" e per i casi di Zika in donne in gravidanza la "Scheda Sorveglianza Zika In Gravidanza"; i tempi di notifica dipendono dal periodo di attività del vettore, fissato convenzionalmente a livello nazionale dal 1/6 al 31/10 di ogni anno.
In assenza di attività del vettore sul territorio la segnalazione di un caso probabile dovrà essere trasmessa entro 24 ore, in presenza di attività del vettore sul territorio la segnalazione di un caso possibile o probabile deve essere trasmessa entro 12 ore, a cura della Direzione Sanitaria di PO, alla U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione competente per territorio.
Questa scheda non sostituisce il modello unico di notifica che deve essere comunque compilato.

Sorveglianza di West Nile Virus e Usutu
*La sorveglianza prevede che il medico segnali "i casi possibili, probabili e confermati" di West Nile Virus escludendo la diagnosi di meningite da virus Toscana. Il medico deve compilare la speciale "**Scheda di segnalazione di caso di West Nile Virus/Usutu virus"**; che deve essere trasmessa entro 12 ore, a cura della Direzione Sanitaria di PO, alla U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione competente per territorio.*
Questa scheda non sostituisce il modello unico di notifica che deve essere comunque compilato.

Sorveglianza e risposta all'encefalite virale da zecche e altre arbovirosi e hantavirus

Il medico che sospetta il caso, sulla base del criterio clinico ed epidemiologico, deve segnalarlo entro 24 ore all'Azienda sanitaria competente ed inviare tempestivamente i campioni per la diagnosi di laboratorio.
Una volta definito che i test diagnostici sono necessari, i campioni dovranno essere inviati, previo contatto telefonico a:
- Laboratorio di riferimento regionale, ove identificato, o, in assenza, di altro laboratorio di riferimento regionale con cui sia stato stipulato un accordo;
- Laboratorio di riferimento nazionale (Dipartimento Malattie Infettive Istituto Superiore di Sanità , tel. 06 .49902663, fax 06.49902813; e-mail: arbo.mipi@iss.it);
Per positività agli esami di laboratorio, il caso probabile e/o confermato, sulla base dell'organizzazione regionale, va segnalato dalla struttura dell'Azienda.

Sorveglianza Listeriosi
Le segnalazioni di casi di listeriosi umana e i focolai epidemici da L.m. devono essere inviate tempestivamente a:

- *Ministero della Salute (malinf@sanita.it);*
- *Istituto Superiore di Sanità (sorveglianza.epidemiologica@pec.iss.it);*

Copia conforme all'originale

- *I focolai epidemici devono essere inoltre segnalati tempestivamente anche a dav.allerta@sanita.it;*

Gli isolati clinici devono essere inviati al laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità (Operational Contact Point dell'ECDC per la listeriosi, DSPVSA@pec.iss.it, tel. 06.49903419), per la caratterizzazione del ceppo.

Nota bene:
Il medico che fa diagnosi di meningite batterica da listeria, deve compilare la scheda di "Sorveglianza delle meningiti batteriche e delle malattie invasive da meningococco, pneumococco, emofilo" che deve essere trasmessa, a cura della Direzione Sanitaria di PO, alla U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione competente per territorio.

Sorveglianza di botulismo

Il medico che fa diagnosi di Botulismo deve compilare la speciale "Scheda di segnalazione di caso Botulismo" che deve essere trasmessa immediatamente, a cura della Direzione Sanitaria di PO, alla U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione competente per territorio.
Questa scheda non sostituisce il modello unico di notifica che deve essere comunque compilato.
La diagnosi di laboratorio dei sospetti clinici, oltre ad escludere eventuali altre malattie a carico del sistema nervoso centrale che rientrano in diagnosi differenziale con il botulismo, è essenziale per contenere il rischio di propagazione della malattia e per la corretta classificazione del caso a fine epidemiologici. Tale diagnosi viene effettuata dimostrando la presenza delle tossine botuliniche nei campioni biologici come il siero, il vomito/contenuto gastrico, le feci, oppure nei residui alimentari consumati dai soggetti che presentano una sintomatologia caratteristica.
La raccolta dei campioni clinici dovrebbe essere effettuata immediatamente dopo la formulazione del sospetto diagnostico e comunque prima dell'eventuale somministrazione dell'antidoto. Tutti i campioni utili per la diagnosi di laboratorio devono essere conservati fino al momento della spedizione al laboratorio in condizioni di refrigerazione (in frigorifero) e non congelati.

Sorveglianza di Paralisi Flaccida Acuta

Il medico che fa diagnosi di Paralisi Flaccida Acuta deve immediatamente compilare la speciale "Scheda di segnalazione iniziale di AFP"; che deve essere trasmessa a cura della Direzione Sanitaria di PO, alla U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione competente per territorio,al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità, e all'Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Sanità Pubblica.
Questa scheda non sostituisce il modello unico di notifica che deve essere comunque compilato.

Sorveglianza forme gravi e complicate di Influenza

La segnalazione dei casi gravi e complicati di influenza confermata deve essere inviata tempestivamente a questo Ministero, Direzione Generale della Prevenzione sanitaria, (Ufficio 5 – Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale) e all'Istituto Superiore di Sanità (Dipartimento di Malattie Infettive), tramite la loro registrazione sul sito web https://www.iss.it/Site/FLUFF100/login.aspx copia dell'apposita scheda (Allegato 20) dovrà essere inviata contestualmente a:

- *malinf@sanita.it*
- *- sorveglianza.influenza@iss.it*

Si rammenta che tutti i casi di influenza con conferma di laboratorio devono essere segnalati con le modalità di notifica previste dal D.M. 15 dicembre 1990 per le malattie della Classe I e si

Copia conforme all'originale

raccomanda la corretta compilazione dei certificati di morte in cui menzionare l'influenza, ove accertata.
Si ricorda inoltre che permangono le raccomandazioni relative all'invio di un campione biologico per i casi gravi e complicati confermati da virus influenzale, al Centro Nazionale per la sorveglianza virologica dell'influenza (NIC, Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena 299 – 00161 Roma; 4 e-mail: flulab@iss.it), previo accordo, per le opportune caratterizzazioni virologiche e il rilevamento di eventuali mutazioni associate a virulenza, nel caso di infezioni da:

a) virus sottotipizzato A(H1N1)pdm09, A(H3N2) o virus B in soggetti non appartenenti a categorie a rischio, ossia con età <65 anni e non aventi patologie concomitanti o croniche favorenti le complicanze, come indicato in Allegato 20;

b) virus A di altro sottotipo, ossia risultante non appartenere ai sottotipi A(H1N1)pdm09 e A(H3N2);

5.5 TABELLA RIASSUNTIVA ISOLAMENTO/PRECAUZIONE AGGIUNTIVE PER ORGANISMO/PATOLOGIA

PRECAUZIONI STANDARD: da adottare sempre, nell'assistenza di TUTTI I PAZIENTI indipendentemente dalla presenza di uno stato infettivo.

PRECAUZIONI AGGIUNTIVE:
***C** = Contatto;*
***D** = Droplet;*
***R** = Respiratoria;*

***CN**= fino al termine del trattamento antibiotico e negativizzazione della coltura;*
***DI**= durata della malattia (in presenza di ferite secernenti – fino al termine delle secrezioni; per patologie gastroenteriche – fino alla cessazione della diarrea);*
***DE**= fino alla completa decontaminazione ambientale;*
***U**= fino al periodo di tempo specificato dopo l'inizio del trattamento antibiotico;*
***Non noto**= Non disponibili evidenze;*

INFEZIONE	PRECAUZIONI AGGIUNTIVE	MATERIALE INFETTANTE	DURATA della PRECAUZIONE	NOTE
Acinetobacter Baumannii MDR				Colonizzato/infetto da MDR: vedi procedura specifica
Adenovirus				
congiuntivite	**C**	Secrezioni oculari	DI	
gastroenterite	**C**	feci	Malattia	Precauzioni da contatto per pazienti incontinenti
Polmoniti adulti		Secrezioni respiratorie		
Ascesso				

Copia conforme all'originale

Presenza di abbondante essudato	**C**	Secrezioni ferita	DI	Non medicare o contenere il drenato fino a quando non smette di drenare o può essere contenuto in una medicazione
Presenza essudato di modesta quantità				La medicazione copre o contiene adeguatamente il drenato
Aspergillosi				Precauzioni da contatto e precauzioni per via area in caso di infezione massiva dei tessuti molli con copioso drenaggio e necessità di ripetute irrigazioni
Brucellosi		Sangue, tessuti		Non trasmessa da persona a persona eccetto raramente attraverso campioni biologici. Somministrare profilassi antibiotica in caso di esposizione in laboratorio.
Campylobacter		Feci	DI	Precauzioni da contatto per persone incontinenti o con pannolino
Candidiasi *(tutte le forme)*				
INFEZIONE	**PRECAUZIONI AGGIUNTIVE**	**MATERIALE INFETTANTE**	**DURATA della PRECAUZIONE**	**NOTE**
Chlamydia trachomatis (tutte le forme)		Secrezioni congiuntivali, rapporti sessuali, secrezioni respiratorie		
Chlamydia pneumoniae				
Clostridium				
C. difficile	**C**	Feci	72 ore dopo la guarigione clinica (cessazione della diarrea)	Vedi procedura aziendale specifica

Copia conforme all'originale

C.perfringens intossicazione alimentare				
C.perfringens gangrena gassosa				Precauzioni da contatto per ferita aperta drenante
Congiuntivite				
Acuta batterica		Secrezioni congiuntivali		
Acuta virale (emorragica)	**C**	Secrezioni congiuntivali	DI	Adenovirus, il più comune, Enterovirus 70, Coxsackie virus A24
Creutzfeldt-Jakob *(CJD,vCJD)*		CSF, tessuti cerebrali, possibili altri tessuti e sangue		Vedi procedura ministeriale
Cytomegalovirus *(CMV)in neonati e pazienti immunocompromessi*				
Difterite				
cutanea	**C**	Secrezioni ferita	CN	Fino alla negativizzazione di 2 esami colturali eseguiti a distanza di 24 ore
faringea	**D**	Secrezioni respiratorie	CN	Fino alla negativizzazione di 2 esami colturali eseguiti a distanza di 24 ore
INFEZIONE	**PRECAUZIONI AGGIUNTIVE**	**MATERIALE INFETTANTE**	**DURATA della PRECAUZIONE**	**NOTE**
Dengue				Non trasmessa da persona a persona se non raramente attraverso trasfusioni
Ebola virus	**C + D + R**	Secrezioni respiratorie, sangue, fluidi corporei	DI	Vedi procedure ministeriali
Encefaliti o encefalomieliti *(vedi agenti eziologici specifici)*				
Enterococcus spp.				E. faecium VRE vedi MDRO

Copia conforme all'originale

Enterovirus (coxsackie gruppo A e B, Echo virus)	**C**	Secrezioni respiratorie, feci	DI	Bambini con pannolone o incontinenti
Epatiti Virali				
HAV		Feci		Provvedere alla vaccinazione post esposizione come raccomandato
- *pazienti incontinenti o con pannolone*	**C**	Feci		Precauzioni da CONTATTO per tutta la durata dell'ospedalizzazione, nei bambini di età inferiore ai 3 anni; bambini 3-14 anni: per 2 settimane dall'inizio dei sintomi; oltre14 anni: 1 settimana dall'inizio dei sintomi Provvedere alla vaccinazione post esposizione come raccomandato dalle misure ministeriali
HBV (acuta e cronica)		Sangue, fluidi corporei	Fino a viremia non rilevabile	In caso di esposizione vedere procedura rischio biologico
HCV (acuta e cronica)		Sangue	Fino a viremia non rilevabile	In caso di esposizione vedere procedura rischio biologico
INFEZIONE	**PRECAUZIONI AGGIUNTIVE**	**MATERIALE INFETTANTE**	**DURATA della PRECAUZIONE**	**NOTE**
HDV		Sangue, fluidi corporei		In caso di esposizione vedere procedura rischio biologico
HEV		Feci		Precauzioni da CONTATTO per persone con pannolini o incontinenti, per tutta la durata malattia
Epiglottite da Haemophilus influenzae B	**D**	Secrezioni respiratorie	24 ore dall'inizio terapia	
Eritema infettivo (vedi Parvovirus B19)				

Copia conforme all'originale

Febbre virale emorragica *(virus Lassa, Ebola, Marburg, Crimean-Congo)*	**C + D + R**	Secrezioni respiratorie, sangue, fluidi corporei	DI	Vedi procedure ministeriali
Foruncolosi stafilococcica		Secrezioni purulente	Fino all'evoluzione crostosa	Da CONTATTO: se il drenato non è contenuto e in neonati e bambini
Gastroenteriti				
Adenovirus *Campylobacter sp* *Colera* *Cryptosporidium sp* *E.Coli enteropatogeno 0157:H7 e altri ceppi produttori di tossine shiga-like* *E.Coli altre specie* *Giardia Lamblia* *Salmonella sp inclusa S. Typhi* *Shighella sp* *Vibrio parahaemolyticus* *Virali* *Yersinia enterocolitia* *Norovirus*		Feci		Da CONTATTO: per i bambini con pannolino o pazienti incontinenti per tutta la durata della malattia e per il controllo di focolai epidemici in Strutture Residenziali
Rotavirus			DI	
INFEZIONE	**PRECAUZIONI AGGIUNTIVE**	**MATERIALE INFETTANTE**	**DURATA della PRECAUZIONE**	**NOTE**
Encefaliti encefalomieliti				Vedi singolo patogeno
Mononucleosi Infettiva *(Epstein-Barr virus)*				
Herpes simplex *(primitivo o ricorrente)*	**C**	Secrezioni da lesione	Fino a evoluzione crostosa	
Encefalite				
Herpes Zoster (Varicella Zoster) Fuoco di				

Copia conforme all'originale

Sant'Antonio				
Disseminato (zoster varicelloso)	**R + C**	Secrezioni respiratorie, vescicole	DI	Le precauzioni Respiratorie/Contatto devono essere rispettate solo da coloro che risultano suscettibili. Non dovrebbero essere assistiti da personale suscettibile se altri operatori immuni presenti, né condividere una stanza con immunodepressi. No raccomandazioni per la protezione degli operatori immuni.
Localizzato con lesioni contenibili			DI	Non dovrebbero essere assistiti da personale suscettibile se altri operatori immuni presenti, né condividere una stanza con immunodepressi.
HIV		Sangue, sperma, liquidi biologici con sangue visibile		In caso di esposizione con paziente a viremia < 200 la PPE (vedi procedura aziendale per rischio biologico) può essere offerta anche se non più raccomandata
Impetigine	**C**	Secrezione lesioni	U 24h	
Infezioni delle cavità chiuse				
Drenaggio aperto in situ; drenaggio limitato o minore		Liquido di drenaggio		Da CONTATTO: in caso di drenato copioso e non contenuto
INFEZIONE	**PRECAUZIONI AGGIUNTIVE**	**MATERIALE INFETTANTE**	**DURATA della PRECAUZIONE**	**NOTE**
Drenaggio chiuso o non drenante				
Infezioni delle ferite				
Maggiori	**C**	Secrezioni ferita	DI	Assenza di medicazione o medicazione non in grado di contenere adeguatamente il drenato
Minori				La medicazione copre e contiene adeguatamente il drenato

Copia conforme all'originale

Infezioni e colonizzazioni da MDRO *Enterobatteri R a carbapenemi (CRE),* *Gram neg. R a 3 Gram neg fermentanti a 4 classi* *VRE* *P. Aeuruginosa MDR* *MRSA* *ESBL* *VISA/VRSA*	**C**			Microrganismi multiresistenti considerati dal programma di controllo delle infezioni, sulla base delle raccomandazioni locali, regionali o nazionali.
Infezioni respiratorie acute *in età pediatrica*	**C**	Secrezioni respiratorie	DI	In attesa della conferma diagnostica aggiungere eventualmente precauzioni Droplet
Influenza				
Stagionale	**D**	Secrezioni respiratorie	5 giorni dall'esordio DI nelle persone immunocompromesse	Stanza singola se disponibile oppure in coorte; evitare la collocazione con pazienti ad alto rischio di sviluppare gravi complicanze. Far indossare la mascherina chirurgica al paziente ogni volta che lascia la propria stanza
INFEZIONE	**PRECAUZIONI AGGIUNTIVE**	**MATERIALE INFETTANTE**	**DURATA della PRECAUZIONE**	**NOTE**
Aviaria *(es: ceppi H5N1, H7N9)*	**C + R+ D**	Secrezioni respiratorie	14 giorni dall'esordio	Protezione anche mucose oculari
Lassa *(vedi febbre virale emorragica)*				
Legionellosi				Non si trasmette da persona a persona

Copia conforme all'originale

Leptospirosi		Acqua, cibi contaminati		Non si trasmette da persona a persona
Malaria				Non si trasmette da persona a persona
Marburg *(vedi febbri virali emorragiche)*				
Meningiti				
da Neisseria Menigitidis o Haemophilus Influenzae B	**D**	Secrezioni respiratorie	U 24h	*Per Meningococco:* la chemioprofilassi è indicata soltanto in caso di contatti stretti, sulla base dell'indagine epidemiologica, e deve essere offerta fino al 10° giorno dal contatto, tenuto conto del massimo periodo d'incubazione della malattia." *Sorveglianza sanitaria* per 10 giorni dall'ultima esposizione. Vaccino post esposizione per controllo epidemie
Virali o da altri batteri				
INFEZIONE	**PRECAUZIONI AGGIUNTIVE**	**MATERIALE INFETTANTE**	**DURATA della PRECAUZIONE**	**NOTE**
Morbillo	**R**	Secrezioni respiratorie	5 giorni dalla comparsa dei sintomi DI nei pazienti immunocompromessi	Stanza singola. Le precauzioni Respiratorie devono essere rispettate da coloro che risultano suscettibili. Precauzioni standard per i non suscettibili. Vaccinazione post esposizione entro le 72 ore dal contatto per prevenire malattia. Soggetti suscettibili esposti che, per particolari condizioni,

Copia conforme all'originale

				non possano essere vaccinati (bambini sotto i 6 mesi di età, donne in gravidanza e persone con grave immunodepressione): Le Ig devono essere somministrate il prima possibile, preferibilmente entro le 72 ore e, comunque, non oltre i 6 giorni dall'esposizione. Si ricorda che nei bambini ≥ 6 mesi di età è preferibile somministrare il vaccino ma, se sono trascorse più di 72 ore, è possibile l'utilizzo delle immunoglobuline. *(Vedere circolare ministeriale 23/06/2017)*
Mycoplasma pneumoniae	**D**	Secrezioni respiratorie	DI	
Parotite epidemica	**D**	Secrezioni respiratorie	5 giorni dall'esordio	Stanza singola. Le precauzioni Respiratorie devono essere rispettate da coloro che risultano suscettibili. Precauzioni standard per i non suscettibili .
INFEZIONE	**PRECAUZIONI AGGIUNTIVE**	**MATERIALE INFETTANTE**	**DURATA della PRECAUZIONE**	**NOTE**
Parvovirus B19	**D**	Secrezioni respiratorie		Mantenere le precauzioni per tutta la durata dell'ospedalizzazione, quando la malattia cronica si manifesta in un paziente immunocompromesso. Nei pazienti con crisi aplastica transitori o crisi emolitica, mantenere le precauzioni per 7 giorni. Non è definita la durata delle precauzioni per i pazienti immunodepressi con persistente positività

Copia conforme all'originale

				alla PCR.
Pertosse	**D**	Secrezioni respiratorie	U 5 giorni	Stanza singola se disponibile. Chemioprofilassi post esposizione per i contatti stretti con prolungata esposizione alle secrezioni. Valutare la somministrazione di vaccino.
Pidocchi				
Della testa (pediculosi)	**C**		U 24 h	
Del corpo				Trasmessi da persona a persona attraverso il vestiario. Indossare camice monouso e guanti al momento della rimozione abiti
Del pube				Trasmessi da persona a persona attraverso contatti sessuali
Pneumocystis carinii		Secrezioni respiratorie		Evitare ricovero in stanza con paziente immunocompromesso
Poliomielite	**C**		DI	
INFEZIONE	**PRECAUZIONI AGGIUNTIVE**	**MATERIALE INFETTANTE**	**DURATA della PRECAUZIONE**	**NOTE**
Rabbia		CSF, saliva, lacrime, tessuti		
RSV virus respiratorio sinciziale	**C**	Secrezioni respiratorie	DI	In età pediatrica e in adulti immunocompromessi indossare la mascherina chirurgica in accordo con le precauzioni standard. Nei pazienti immunocompromessi estendere la durata delle precauzioni da contatto a causa della prolungata eliminazione del virus.

Copia conforme all'originale

Rosolia	**D**	Secrezioni respiratorie	7 giorni dopo l'esordio del rash	Stanza singola. Le precauzioni Respiratorie devono essere rispettate da coloro che risultano suscettibili. Precauzioni standard per i non suscettibili .
Rosolia congenita	**C**	Secrezioni respiratorie	Fino ad un anno di età con negativizzazione colture naso faringee e urine	Precauzioni Standard se colture di secrezioni rinofaringee e urine sono ripetutamente negative, a partire dai 3 mesi di età
SARS *(Sindrome Respiratoria Acuta Severa)*	**C + D + R**	Secrezioni respiratorie e fluidi infetti	DI + 10 gg dalla risoluzione della febbre	Stanza a pressione negativa. Vedi disposizioni ministeriali
Scabbia	**C**		U 24 h	Vedi specifica procedura aziendale
Scarlattina *(vedi malattia da streptococco gruppo A)*				
Sifilide *(treponema pallidum)*		Lesioni cutanee, sangue, sperma, latte materno		
Sindrome da shock tossico *(malattia da stafilococco, malattia da streptococco)*		Secrezioni respiratorie		Precauzioni per Droplet per le prime 24 ore dopo l'implementazione della terapia antibiotica se l'eziologi più probabile è lo streptococco di gruppo A
INFEZIONE	**PRECAUZIONI AGGIUNTIVE**	**MATERIALE INFETTANTE**	**DURATA della PRECAUZIONE**	**NOTE**
Stafilococco aureo				
Cute, ferite, ustioni: estese	**C**		DI	Non coprire o medicare senza contenere il drenato adeguatamente
Cute, ferite, ustioni: minori o limitate				Coprire con medicazione che contenga adeguatamente il drenato
Enterocoliti		Feci		Da CONTATTO nei confronti di bambini con pannolini o incontinenti, per tutta la durata della malattia

Copia conforme all'originale

Polmonite				
S. Areus Meticillino-resistente (MRSA)	**C**	Secrezioni, tessuti	Negativizzazione colture (vedi nota)	A 48 ore termine terapia e negativizzazione colture da sito primario e 2 nasali a 72 h di distanza
Stafilococco VRSA/VISA (vedi altri MDRO)	**C**	Secrezioni, tessuti contenenti MRSA	Vedi nota	Isolare in stanza singola
Streptococco gruppo A				
Cute, ferite, ustioni: estese	**C + D**		U 24 h	Non coprire o medicare senza contenere il drenato adeguatamente
Cute, ferite, ustioni: minori o limitate				Coprire con medicazione che contenga adeguatamente il drenato
Endometrite (sepsi puerperale)				
Faringite in età pediatrica	**D**		U 24 h	
polmonite	**D**		U 24 h	
Scarlattina in età pediatrica	**D**		U 24 h	
Malattia invasiva grave	**D**		U 24 h	Adottare precauzioni da contatto per le ferite drenanti come sopra; profilassi antimicrobica in condizioni selezionate
Streptococco gruppo B, neonatale				
INFEZIONE	**PRECAUZIONI AGGIUNTIVE**	**MATERIALE INFETTANTE**	**DURATA della PRECAUZIONE**	**NOTE**
Streptococco gruppo non A e non B				
Tigna (dermatofitosi, dermatomicosi, tricofizia)				Rari episodi di trasmissione umana
Tubercolosi (mycobacterium tubercolosis)				Vedi note
Extra polmonare con lesioni drenanti	**C+R**	Materiale caseoso (lesioni drenanti)		Interrompere precauzioni alla cessazione della fuoriuscita di materiale caseoso o 3 colture consecutive negative.

Copia conforme all'originale

				Escludere tubercolosi polmonare attiva.
Forma polmonare bacillifera o laringea (Confermata)	**R**	Secrezioni respiratorie		Vedi procedura specifica. Interrompere le precauzioni solo quando il paziente in trattamento specifico è migliorato clinicamente e ha 3 campioni consecutivi, raccolti in giorni separati, negativi per BAAR all'esame microscopico.
Forma polmonare bacillifera o laringea (Sospetta)	**R**	Secrezioni respiratorie		Interrompere le precauzioni solo quando la probabilità di TB è ritenuta trascurabile e: 1. una diagnosi diversa spiega la situazione clinica; 2. il risultato di 3 campioni di espettorato per BAAR è negativo. Ognuno dei 3 cmpioni deve essere raccolto a distanza di almeno 8-24 h e almeno 1 deve esser raccolto di prima mattina.
Ulcere da pressione infette (ulcere da decubito)				
INFEZIONE	**PRECAUZIONI AGGIUNTIVE**	**MATERIALE INFETTANTE**	**DURATA della PRECAUZIONE**	**NOTE**
Rilevanti	**C**		DI	Se non coperte da medicazioni o la medicazione non contiene il drenato adeguatamente.
Di limitata importanza				Se coperte da medicazioni o con contenimento del drenato
Varicella Zoster	**R + C**	Secrezioni respiratorie, vescicole	Isolamento Respiratorio fino al 5° giorno dalla comparsa del primo rash	

Copia conforme all'originale

5. Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione

Il responsabile della diffusione è il direttore della SOS Vigilanza ICA;

- *Il luogo di conservazione è presso la segreteria della struttura SOS Vigilanza ICA;*
- *Il luogo di conservazione dell'originale presso la segreteria della struttura SOS Vigilanza ICA;*
- *La procedura è consultabile attraverso i siti intranet aziendali;*

6. Monitoraggio e controllo

- *Il monitoraggio si effettua attraverso verifiche a campione sulle modalità di infection control attuate;*
- *Organizzazione di audit proattivi sulla gestione del paziente colonizzato-infetto;*
- *Qualora si riscontrino problemi verranno indicate le eventuali azioni di miglioramento;*

7. Revisione

La revisione si effettua su motivazioni sostanziali, e comunque ogni tre anni.

8. Allegati

Allegato 1 – Sequenza di vestizione/rimozione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);

Allegato 2 – Procedure attivazione reperibilità U.F Igiene e Sanità Pubblica ex Ausl;

9. Riferimenti

Denominazione documento	Fonte/Scaricabile/ Consultabile
Scheda di Notifica Malattia infettiva e diffusiva	*Scaricabile attraverso il sito intranet aziendale e attraverso il link: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=902&area=Malattie%20infettive&menu=vuoto*
Scheda di Sorveglianza della Legionellosi	*Scaricabile attraverso il sito intranet aziendale e attraverso il link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2362_allegato.pdf*
Scheda per la Notifica e l'inchiesta epidemiologica su caso di Malaria	*Scaricabile attraverso il sito intranet aziendale e attraverso il link: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2016&codLeg=57366&parte=1%20&serie=null*
Scheda di Sorveglianza delle malattie batteriche invasive e meningiti batteriche	*Scaricabile attraverso il sito intranet aziendale e attraverso il link: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=59229&parte=1%20&serie=null*
Scheda per la Sorveglianza epidemiologica della Malattia di Creutzfeld-Jakob	*Scaricabile attraverso il sito intranet aziendale e attraverso il link: http://www.iss.it/binary/rncj/cont/1.1113394759.pdf*
Scheda di Notifica Classe III – Tubercolosi e Micobatteriosi	*Scaricabile attraverso il sito intranet aziendale e attraverso il link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_902_listaFile_itemName_5_file.pdf*
	Scaricabile attraverso il sito intranet aziendale e

Copia conforme originale

Scheda Sorveglianza Esito di Trattamento nella TBC polmonare	*attraverso il link: https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwie37_LuuvYAhWH5qQKHduSCWQQFgguMAA&url=http%3A%2F%2Frepository.regione.veneto.it%2Fpublic%2F9f3ef6d67d6ddded04e0b65ba8d52338.php%3Flang%3Dit%26dl%3Dtrue&usg=AOvVaw1W-oMfF5U6ubV8xN47q90c*
Scheda di Notifica di caso di Infezione da virus della Rosolia in gravidanza	*Scaricabile attraverso il sito intranet aziendale e attraverso il link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_902_listaFile_itemName_12_file.pdf*
Scheda di Notifica di caso di Infezione/Sindrome da Rosolia congenita	*Scaricabile attraverso il sito intranet aziendale e attraverso il link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_902_listaFile_itemName_13_file.pdf*
Scheda di Sorveglianza Integrata Morbillo – Rosolia	*Scaricabile attraverso il sito intranet aziendale e attraverso il link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_902_listaFile_itemName_10_file.pdf*
Istruzioni per l'utilizzo e l'invio del kit per il prelievo dei casi sospetti di morbillo	*Scaricabile attraverso il sito intranet aziendale*
Scheda di Notifica e Sorveglianza delle Arbovirosi	*Scaricabile attraverso il sito intranet aziendale e http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=60017&parte=4&serie=*
Scheda di Notifica e Follow-up dei casi in di virus Zika in gravidanza;	*Scaricabile attraverso il sito intranet aziendale e attraverso il link: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=60017&parte=5&serie=*
Scheda di segnalazione di caso di West Nile Virus/Usutu Virus	*Scaricabile attraverso il sito intranet aziendale e attraverso il link: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf;jsessionid=12eU7vBw5NO3xETn7zZEew__.sgc3-prd-sal?anno=2017&codLeg=59579&parte=1%20&serie=null*
Scheda di Notifica e Sorveglianza TBE e altre arbovirosi e hantavirus	*Scaricabile attraverso il sito intranet aziendale e attraverso il link: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=60151&parte=4&serie=*
Scheda segnalazione caso di Botulismo	*Scaricabile attraverso il sito intranet aziendale*
Scheda di sorveglianza Paralisi Flaccide Acute	*Scaricabile attraverso il sito intranet aziendale e attraverso il link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_902_listaFile_itemName_7_file.pdf*
Scheda per la Notifica delle forme gravi e complicate e dei decessi da virus influenzali	*Scaricabile attraverso il sito intranet aziendale e attraverso il link: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2018&codLeg=61660&parte=1%20&serie=null*

- *Monitoraggio dell'andamento delle forme gravi e complicate di influenza confermata, stagione 2017-2018 – Circolare ministeriale del 27 Novembre 2017;*
- *Ministero della Salute Circolare 28.06.17 - Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2017;*

non è originale

- *Piano Nazionale di sorveglianza e risposta all'encefalite virale da zecche e altre arbovirosi e hantavirus non sottoposti a specifici piani di sorveglianza e risposta – 2017;*
- *Sorveglianza e prevenzione della Listeriosi – Circolare ministeriale 2017;*
- *Ministero Salute Circolare 16.6.16: Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2017;*
- *Circolare Ministero Salute 12.07.2017 Botulismo e sicurezza alimentare: indirizzi operativi);*
- *Ministero Salute Circolare 9.5.2017: Prevenzione e controllo delle malattie batteriche invasive prevenibili con vaccinazione;*
- *Circolare Ministero della Salute del 04.04.17 – Situazione epidemiologica del Morbillo – indicazioni operative per la gestione dell'epidemia in atto;*
- *Protocollo Per La Sorveglianza Nazionale Delle Malattie Invasive Da Meningococco, Pneumococco Ed Emofilo E Delle Meningiti Batteriche In Italia del 12/03/2007 - Aggiornamento 11 Aprile 2016;*
- *Circolare Ministero Salute 27.12.16: Prevenzione e controllo della malaria in Italia;*
- *Intesa Conferenza Stato-Regioni del 07/05/2015 "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi";*
- *Decreto Giunta Regione Toscana - DGR 571/2015 "Prevenzione della diffusione del meningococco C in Toscana. Aggiornamento calendario e direttive Aprile 2015";*
- *Delibera Regione Toscana n. 677 del 4.8.14: Linee di indirizzo per il controllo della tubercolosi;*
- *Procedure operative per la gestione di casi sospetti, probabili o confermati e contatti di malattia da virus Ebola (MVE) – Istituto Lazzaro Spallanzani, agg.to 10.12.2014;*
- *Circolare Ministero Salute 26.2.13: Sorveglianza e controllo delle infezioni da batteri produttori di carbapenemasi;*
- *Infezione da virus influenzale A(H7N9) nell'uomo/"Infezione da nuovo Coronavirus – maggio 2013;*
- *Circolare Ministero Salute 12.10.12: Sorveglianza, prevenzione e misure di controllo del botulismo;*
- *Prevenzione e controllo delle infezioni da C. Difficile, Documento di indirizzo, Revisione n. 1, SIMPIOS 2011;*
- *Intesa Conferenza Stato-Regioni del 23.3.11: piano Nazionale per l'eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita 2010-2015;*
- *Delibera G.R. Toscana n. 657 del 12.7.10: Nuove linee guida per la corretta gestione delle malattie veicolate da alimenti;*

Copia conforme all'originale

- *I batteri gram negativi MDR : un problema emergente e di attualità. Indicazioni gestionali Consiglio Direttivo Simpios, 2010;*
- *Aggiornamento delle raccomandazioni per le attività di controllo della Tubercolosi "Gestione dei contatti e della tubercolosi in ambito assistenziale" Linee Guida Ministero della Salute, 2010;*
- *Circolare Ministero Salute n. 2 del 5.10.08: Notifica obbligatoria dell'infezione da rosolia e della sindrome/infezione da rosolia in gravidanza;*
- *Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, CDC 2008;*
- *Decisione della Commissione Europea del 28 aprile 2008 recante modifica della decisione 2002/253/CE che stabilisce la definizione di caso ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 159/46 del 18/06/2008);*
- *Decreto Ministero Salute 31.3.08 Sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV;*
- *Lettera Circolare Ministero Salute 20.4.07: Istituzione sistema sorveglianza speciale morbillo;*
- *Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings, CDC 2007;*
- *Management of Multidrug-Resistant Organisms in Healthcare Settings, CDC 2006;*
- *Decreto Ministro Salute 21.12.01: Sorveglianza obbligatoria della Malattia di Creutzfeldt-Jakob;*
- *Decreto Ministero della Sanità 15/12/1990 "Sistema informativo delle malattie infettive";*
- *Febbri emorragiche virali (FEV) – Raccomandazioni ed incitazioni per il trasporto*

10. Indice revisioni

Revisione n°	Data emissione	Tipo modifica	Titolo
3	29/12/2017	REVISIONE procedura AS/PR/36 del 27/05/2013	*Gestione del paziente colonizzato/infetto in ambiente ospedaliero*

11. Lista di diffusione

- *Direzione sanitaria aziendale;*
- *SOS Vigilanza e Controllo Infezioni correlate all'Assistenza;*
- *Direzioni mediche di presidio;*

Copia conforme all'originale

- *Tutti i Dipartimenti ospedalieri e territoriali;*
- *Dipartimenti Professionali:*

Copia conforme all'originale